

INFECTION AIGUË DES PARTIES MOLLES (ABCÈS, PANARIS, PHLEGMON DES GAINES)

- Diagnostiquer et traiter une infection aiguë des parties molles (abcès, panaris, phlegmon des gaines).
- Identifier les situations d'urgence et celles nécessitant une hospitalisation, initier la prise en charge.

Zéros	INFECTIONS AIGUËS DES PARTIES MOLLES	
Panaris : - Staphylocoque doré - 3 stades : - o Invasion : asymptomatique - o Phlegmasique : pas de fièvre ; traitement médical ambulatoire - o Collecté : douleurs pulsatiles nocturnes, fièvre ; traitement chirurgical : excision, prélèvements, lavage, cicatrisation dirigée, immobilisation + ATB : augmentin - Radiographie de la main : ostéite ? arthrite ? - SAT-VAT - Rééducation Phlegmons des gaines : - Attitude en crochet irréductible du doigt - Douleur provoqué à la palpation du cul de sac supérieur - Rechercher et traiter la porte d'entrée - 3 stades : - o Inflammatoire - o Purulent - o Nécrosé : disparition du crochet - Traitement chirurgical : mise à plat (synovectomie), prélèvement, lavage, excision des tissus nécrosés, cicatrisation dirigée, immobilisation, ATB (Augmentin) - SAT-VAT - Rééducation	1. Définitions – Physiopathologie :	
	Abcès - Amas de pus collecté en une cavité néoformée aux dépens des tissus environnants - Accompagné de signes inflammatoire (abcès chaud) ou non (abcès froid)	Empyème - Collection purulente dans une cavité naturelle (sinus, plèvre, sous-dural)
	Panaris - Infection primitive aiguë limitée aux plans cutanés ou sous-cutanés d'un doigt	Phlegmon - Inflammation du tissu conjonctif superficiel ou profond péri-viscéral - Gaiens péri-tendineuses, tissu péri-amygdalien
	Pathogénie - Contamination par inoculation directe le plus souvent puis diffusion - Bactéries : S. aureus Streptocoques β -hémolytique du groupe A C. perfringens (gangrène gazeuse) C. tetanii...	Facteurs favorisants - <u>Généraux</u> : Diabète , Immunodépression : éthyisme chronique, corticothérapie Toxicomanie - <u>Locaux</u> : soins de manucure, périonyxis, morsure...
	2. Diagnostic :	
	Interrogatoire - Antécédents personnels médico-chirurgicaux et familiaux - Prise de traitement - Facteurs favorisants : diabète, immunosuppression - Ancienneté et circonstances d'apparition de la plaie - Mécanisme lésionnel : recherche de la porte d'entrée - Main dominante - Profession - Statut vaccinal antitétanique - Signes fonctionnels : Douleurs diurnes ou nocturnes, pulsatiles Altération de l'état général - Pré-opératoire : Heure du dernier repas Allergies	
	Examen physique	Local - Porte d'entrée - Signes d'inflammation, collection de pus - Extension de l'infection Loco-régional - Douleur à la percussion du cul-de-sac proximal de la gaine - Signes de diffusion : trainée de lymphangite - Palpation des aires ganglionnaires Général - Signes généraux : Température Signes de sepsis et de sepsis sévère - Auscultation cardiaque : recherche d'une endocardite - Examen général à la recherche d'une métastase septique - Glycémie capillaire
	Paraclinique	Biologie - NFS, CRP : syndrome inflammatoire biologique - Glycémie veineuse : recherche d'un diabète - Bilan rénal : ionogramme sanguin, urée et créatininémie - Bilan hépatique Infectieux - Prélèvements bactériologiques + antibiogramme - Hémocultures aéro-anaérobies si signes généraux Imagerie - Radiographies : Corps étrangers Emphysème (gangrène gazeuse) Signes d'ostéo-arthrite Fracture - Echographie cardiaque si suspicion d'endocardite

3. Abscesses :

Stades évolutifs	Invasion	- Asymptomatique - Aucun examen paraclinique
	Phlegmasique	- Inflammation locale - Aucun examen paraclinique
	Stade collecté	- Inflammation - Douleur pulsatile - Fluctuant à la palpation
Prise en charge	Stades invasif et phlegmasique	- Traitement médical : Pansements antiseptiques quotidiens Antibiothérapie : Augmentin® Immobilisation
	Stade collecté	- Traitement médical : cf. ci-dessus - Traitement chirurgical : Excision des tissus infectés/nécrotiques Prélèvements bactériologiques Mise à plat de l'abcès

4. Panaris :

Formes cliniques	Cutané	- Péri-unguéal, sous-unguéal : > 70% des panaris - Anthracoïde : centré sur un follicule pilo-sébacé - Bouton de chemise : Face palmaire du doigt Communique avec parties molles par un pertuis
	Sous-cutané	- Pulpaire (face palmaire) - Face dorsale de P ₁ /P ₂
Stades évolutifs	Stade d'invasion	- Inoculation septique à l'interrogatoire - Asymptomatique
	Stade phlegmasique	- Signes locaux : douleurs diurnes modérées, inflammation - Pas de signes locorégionaux ou généraux
	Stade collecté	- Signes généraux - Signes locorégionaux - Signes locaux : douleurs nocturnes insomniantes et inflammation
Prise en charge	Stades invasif et phlegmasique	- Traitement médical en ambulatoire - Symptomatique : Traitement antalgique - Spécifique : Bains antiseptiques pluriquotidiens de chlorhexidine Pansements quotidiens Pas d'antibiothérapie - Mesures associées : Mise à jour du statut vaccinal antitétanique Arrêt de travail si travail dans la restauration Education du patient
	Stade collecté	- Hospitalisation en urgence - Symptomatique : traitement antalgique - Spécifique : Médical : Antibiothérapie : Augmentin® 7 jours Chirurgical : Excision des tissus nécrosés Prélèvements bactériologiques Ablation d'un corps étranger Recherche d'un pertuis Lavage abondant Pas de suture : cicatrisation dirigée - Mesures associées : Immobilisation du doigt Rééducation Mise à jour du statut vaccinal antitétanique
Evolution	Evolution	- Favorable sous traitement bien conduit
	Complications aiguës	- Extension du foyer infectieux : cellulite, phlegmon, arthrite - Endocardite aiguë
	Complications secondaires	- Evolution subaiguë : antibiothérapie inadaptée - Récidive
	Complications tardives	- Raideur séquellaire - Dystrophie unguéale et cicatrice inesthétique

5. Phlegmon des gaines :

Formes cliniques	- Gaine digito-carpienne externe : pouce - Gaines digitales des doigts médians - Gaines digito-carpienne interne : auriculaire - Phlegmon à bascule : entre les deux gaines digito-carpiennes	
	Stades évolutifs	- Pas de signes généraux - Loco-régional : Adénopathie Lymphangite - Local : Main en pronation Attitude irréductible en crochet du doigt Douleurs pulsatiles sur le trajet de la gaine Douleur à la palpation du cul de sac proximal de la gaine
		- Idem - Signes généraux
		- Disparition de l'attitude en crochet - Rupture tendineuse
	Prise en charge	- Hospitalisation en urgence - Urgence médico-chirurgicale
		- A jeun - Pose d'une voie veineuse périphériques
		- Traitement antalgique IV - Immobilisation + surélévation - Rééducation - Arrêt de travail - Surveillance quotidienne
		- Médical : antibiothérapie : Augmentin® 7 jours - Chirurgie en urgence : Mise à plat de la gaine digitale Prélèvements bactériologiques Lavage abondant Excision des tissus nécrosés Ablation d'un corps étranger Traitement de la porte d'entrée Cicatrisation dirigée
		- Immobilisation en position de fonction + surélévation - Rééducation - Mise à jour du statut vaccinal antitétanique SAT-VAT - Arrêt de travail - Surveillance quotidienne
	Evolution	- Favorable aux stades I et II
		- Extension du foyer infectieux : cellulite, ostéite, arthrite - Rupture tendineuse - Endocardite aiguë
		- Raideur séquellaire - Troubles trophiques - Doigt en crochet irréductible (stade II) - Perte de flexion du doigt (stade III)